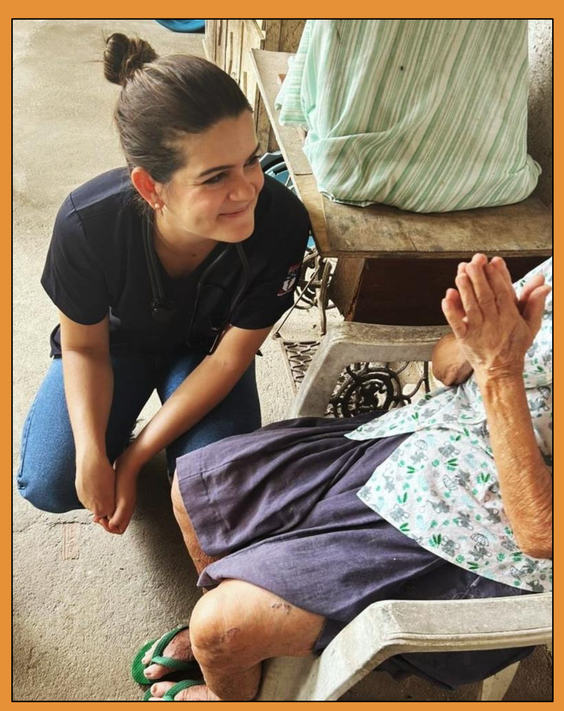
2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

MEDICINA HUMANIZADA SE ENSINA? APRENDIZAGENS A PARTIR DA PRECEPTORIA E DAS VISITAS DOMICILIARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Autores: BEATRIZ MOURA NUNES[1]; MARIA VITÓRIA DE SOUZA MOREIRA[1]; JOÃO PEDRO RICARDO RAMALHO NUNES[1]; ROBERTA DE ALBUQUERQUE WANDERLEY[1]; MARIA DEYSIANE PORTO DE ARAÚJO[1].
[1] Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca.



Imagens 1 e 2: Estudantes de Medicina em contato com pacientes durante visitas domiciliares.

CUIDAR OU APENAS TRATAR: QUE MÉDICOS ESTAMOS FORMANDO?

A experiência no território, mediada pelo Método Clínico Centrado na Pessoa e pela preceptoria, revela que formar vai além da técnica: é construir vínculo, escuta e cuidado real.

Introdução

A formação médica pressupõe o desenvolvimento de competências clínicas e comunicacionais orientadas pelo Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP). Nesse contexto, as visitas domiciliares constituem relevante cenário privilegiado de ensino-aprendizagem na Atenção Primária à Saúde (APS) ao possibilitar a inserção do estudante no território e o contato direto com as condições reais de vida dos usuários.

Objetivos

Relatar a experiência do internato em Medicina de Família e Comunidade, evidenciando a aplicabilidade do MCCP a partir do acompanhamento de visitas domiciliares sob supervisão preceptorial.

Métodos

Trata-se de um relato de experiência do internato em MFC, baseado no acompanhamento de visitas domiciliares supervisionadas, realizadas entre dezembro de 2025 e março de 2026. As atividades envolveram inserção territorial, contato direto com a comunidade e atuação em diferentes contextos clínicos e socioculturais, com ênfase em escuta qualificada, acolhimento e compreensão ampliada das demandas.

Resultados

A experiência evidenciou a aplicação do MCCP por meio de comunicação empática, valorização das narrativas e decisões compartilhadas, ampliando a compreensão do processo saúde-doença no contexto familiar e social. A inserção no território fortaleceu competências clínicas e o vínculo com os usuários, enquanto a preceptoria integrou teoria e prática, estimulando reflexão crítica. Como resultado, houve uma atuação mais humanizada, centrada na pessoa e com maior adesão ao tratamento.

Conclusão/Considerações finais

A vivência reforça a preceptoria como dispositivo pedagógico essencial e sugere que a inserção ativa do estudante em cenários territoriais, mediada pelo MCCP, fortalece competências relacionais, clínicas e éticas alinhadas à atenção integral.

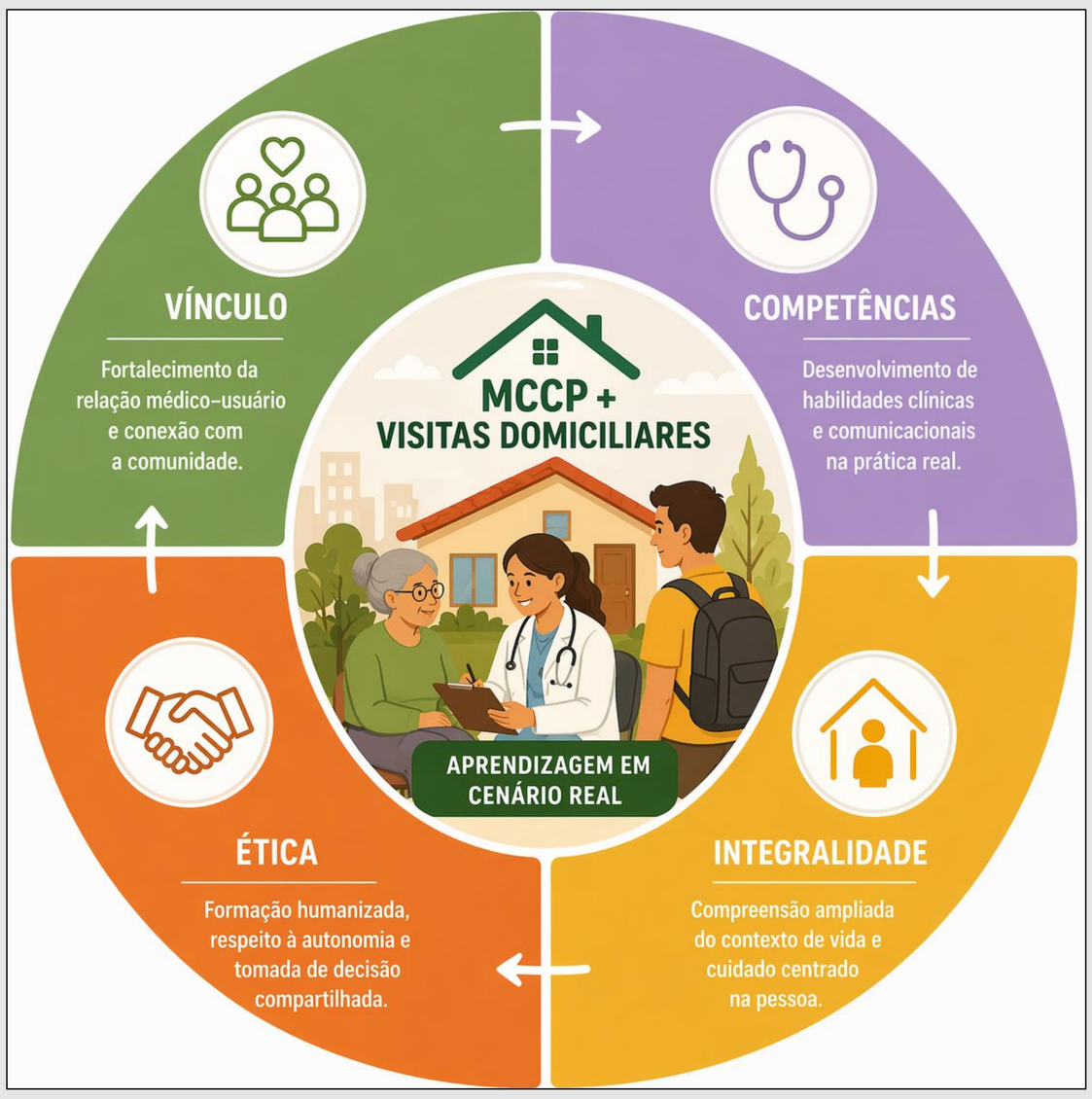


Imagem 3: Formação médica baseada no vínculo, no desenvolvimento de competências, na ética e na integralidade do cuidado, a partir da articulação entre visitas domiciliares e a aplicação do MCCP.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), CAMPUS ARAPIRACA
BEATRIZ MOURA NUNES
ESTUDANTE DE MEDICINA

E-mail: beatriz.moura@arapiraca.ufal.br
Contatos: (82) 99910-5901

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS